

L'UTERUS

PR A.DIA

1. Introduction

1.1 Définition : * Féminin creux médian contractile pelvis.

1.2. Intérêt : Modifications cycliques >menstruations.

- * Gestation. Développement œuf fécondé. Expulsion fœtus à maturité.
- * Pathologies tumorales (fibromyomes; cancers)
- * Pathologies dégénératives (prolapsus).
- * Rapports uretère pelvien => chirurgie.

2. Anatomie descriptive

2.1 Configuration externe

. Piriforme : corps. isthme. col.

2.1.1 Le corps :

- cône aplati
- 2 faces :
 - vésicale, antéro-inférieure.
 - Intestinale, postéro-supérieure.
- 2 bords :
 - droit et gauche
- 1 base : fundus utérin, convexe
- 2 angles :
 - cornes utérines
 - ligaments ronds; ligaments propres ovaire
 - trompes utérines.

2.1.2 L'isthme

- Partie rétrécie utérus
- Entre corps et col.

2.1.3 Le col

- Cylindrique
- Insertion au vagin : - Oblique en bas et en avant.
 - culs-de-sac
- Partie supra-vaginale du col:
 - réduite.
 - se continue avec le corps
- Partie vaginale du col
 - volumineuse
 - rose pâle
 - orifice externe du col: + aspect variable. parité
 - + canal cervical
 - + lèvres ant. et post du col.
 - visible au spéculum => prélèvements
 - Toucher vaginal.

2.1.4. Direction

- Antéfléchi : axe du corps utérin et axe du col : 120° ; en bas et en avant.
Antéversé : axe du col et axe du vagin = 90° .

- ❖ Pathologie :
 - * Rétroversion : fond utérin en arrière.
 - * Rétroflexion : angle corps – col ouvert en arrière.

2.1.5 Consistance – Dimensions

- Forme mais élastique
- Poids : - 50g nullipare
- 70g multipare
- Mesures externes
 - Nullipare
 - L = 7cm dont 4cm pour corps et 2,5cm pour col.
 - l = 4cm à base, 3cm à partie moyenne.
 - épaisseur : 2cm
 - Multipare : dimensions du corps augmentent.
- Mesures internes
 - Capacité = 3-4 cc
 - L = 5,5cm (nullipare) dont 2,5cm pour le col et 0,5cm pour l'isthme.

2.2 Configuration interne

- Cavité utérine : cavité corporeale et canal cervical.
- Cavité corporeale :
 - triangulaire et virtuelle .
 - angles supéro-latéraux => ostium utérin des trompes.
 - dispositif utérin.
- Canal cervical :
 - +cavité réelle. Fusiforme. glaire cervicale. plis palmés
 - +ostium interne du col

2.3 Structure

- Séreuse péritonéale
- Musculeuse ou myomètre:
 - couche externe, mince
 - couche moyenne , très épaisse, plexiforme et vasculaire
 - couche interne, fibres musculaires circulaires
- Tunique interne ou endomètre ou muqueuse.

2.4 Fixité

2.4.1 Ligaments ronds

- L = 10 – 15cm
- Cornes utérus – grandes lèvres et mont du pubis
- vasculaires.

2.4.2 Ligaments utéro-sacrés

- Sacrum - Face post isthme, col et fornix.
- Plis utéro-sacraux.

2.4.3 Ligaments vésico-utérins

- Fibres musculaires lisses
- Isthme – vessie

2.4.4 Paramètres et paracervix

- Chaque côté isthme, partie supra-vaginale du col et fornix - paroi pelvienne latérale.

3. Rapports

3.1 Péritonéaux

- En avant : - corps et isthme. face supérieure vessie => cul-de-sac vésico-utérin.
- . En arrière : - toute face intestinale - 1/3 supérieur , face postérieure vagin - cul-de-sac recto-génital.

3.1.1 rapports intra-péritonéaux

- Face vésicale : - face supérieure vessie.
- Face intestinale : - anses grêles
- côlon sigmoïde.
- . Bords: - mésomètre et vaisseaux utérins.
- Fundus : - anses grêles
- grand omentum.

3.1.2 Rapports sous péritonéaux

- en avant : septum vésico-utérin : * partie supra-vaginale col et isthme
- fosse rétro-trigonale base vessie
* limité par ligts vésico-utérins, latéralement.
- Latéralement : - en bas : * paramètre
* uretère pré-croisé par artère utérine – 1,5cm de l'isthme; rétro-croisé par artère vaginale.
* veines, lymphatiques et nerf utérins.

3.1.3 Rapport de la partie vaginale du col

Par intermédiaire du vagin.

- en avant : - trigone vésical - partie terminale uretère pelvien
- Latéralement : - paracervix
 - + artère vaginale, veines et lymphatiques vaginaux
 - + branches vésico-vaginales nées de l'artère utérine.
- En arrière : - Rectum - cul-de-sac recto-génital.

4-Vascularisation – Innervation

4. 1 Vascularisation

4.1.1 Artère utérine

- Origine : AII
- Trajet : - L: 15cm; cellules : 3mm
 - segment rétro-ligamentaire ou pariétal
 - segment sous-ligamentaire ou paramétrial
 - segment intra-ligamentaire ou mésométrial ou viscéral
- Terminaison : - corne utérine
 - 3 rameaux : * tubaire médial
 - * ovarique médial
 - * récurrent du fundus utérin.

- Rapports

- Segment pariétal : * artères ombilicale et obturatrice, veines et lymphatiques utérins, en avant
 - * veines utérines postérieures; artère et veines vaginales, lymphatiques vaginaux, en arrière.
- Segment sous-ligamentaire : * précroise uretère, 1,5cm du fornix vaginal, en avant
 - * plexus veineux, lymphatiques utéro-vaginaux
 - * plexus hypogastrique inférieure, en arrière.
- Segment intra-ligamentaire : * contre bords utérus. plexus veineux et lymphatiques. nerfs utérins.

- Branches collatérales

- Rameau urétérique
- Rameaux vésico-vaginaux
- Artère cervico-vaginale
- Rameaux cervicaux.

4.1.2 Artère ovarique

- Origine : - AO L2
- Trajet :
 - croise vci et m grand psoas
 - croise uretère (L3 – L4)
 - ligament lombo-ovarien
 - Au DS: croise vaisseaux iliaques et uretère
 - pénètre dans ligament large.
- Terminaison : - extrémité supéro-latérale. Ovaire
 - rameau ovarique latéral
 - rameau tubaire latéral.

4.1.3 Artère du ligament rond

- Origine : artère épigastrique inférieure (crosse)
- Trajet : suit ligament rond
- Terminaison : - rameaux pour grandes lèvres
 - rameaux pour corne utérine.

4.1.4 Anastomoses

- Entre artères utérines
- Entre artères utérines et artères ovariques, vaginales, AO.

4.1.5 Veines

- Sang veineux collecté dans plexus veineux utérins => veines utérines et ovariques => veines iliaques internes.

4.1.6 Lymphatiques

- Origine :
 - + muqueux
 - + musculaire
 - + sous-séreux
 - + séreux
- Collecteurs
 - Pelviens :
 - + pédicule iliaque externe
 - * dans paramètre
 - * voie principale > nœuds iliaques externes médiaux et obturateurs
 - + pédicule iliaque interne
 - * dans paracervix
 - > nœuds iliaques internes et inter iliaques
 - + voie sacrale accessoire
 - * dans ligaments utéro-sacrés
 - > nœuds du promontoire.
 - Inguinaux
 - * suivent ligament rond
 - > nœuds inguinaux superficiels médiaux.

4.2 Innervation

- Origine : plexus hypogastrique inférieur
- Pédicule corporel : 3 à 4 nerfs
- Pédicule cervico-isthmique : 4 à 5 nerfs.

5 Exploration

5.1 Clinique

- Toucher vaginal – palper abdominal
- Examen au spéculum

5.2 Paraclinique

- Echographie :
 - abdominale
 - endovaginale
- Hystérosalpingographie
- Imagerie médicale : IRM
- Hystéroscopie. Coelioscopie.

Conclusion